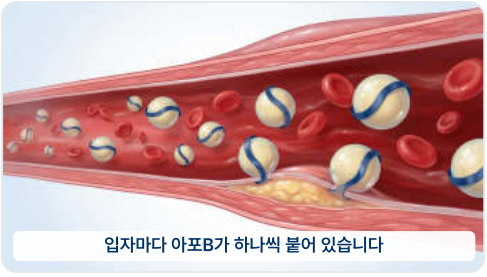
Lp(a)·아포B — 새로 보는 혈관 위험 검사

2026년에 새로 보는 두 가지 혈액검사로, 콜레스테롤(LDL)과는 별도로 혈관 위험을 보여줍니다. Lp(a)는 타고난 유전 수치, 아포B는 혈관벽에 쌓일 수 있는 입자의 개수를 반영합니다.

두 검사가 각각 보는 것



입자마다 아포B가 하나씩 붙어 있습니다

짧게 정리하면

Lp(a)는 **대부분(70~90% 이상) 유전으로 정해지는** 지질 입자로, LDL 콜레스테롤과 따로 측정합니다

아포B는 LDL을 포함해 혈관벽에 쌓일 수 있는 입자마다 하나씩 붙는 단백질입니다 — 그래서 **입자의 개수**를 보여줍니다

Lp(a)가 높으면 **심근경색·허혈성 뇌졸중** 위험이 올라갑니다

자세한 설명은 진료실 설명 슬라이드에서 보실 수 있습니다

내 Lp(a) 결과 읽는 법

결과(nmol/L)	구간	할 일
75 미만	**낮음**	정기 진료로 전체 혈관 위험도를 재평가합니다
75~125	**경계**	경계치이면 **재검을 고려**합니다 · 금연, 혈압·혈당 관리
125 이상	**위험 증가**(위험 증강 인자 — 다른 위험요인과 함께 치료 강도를 정할 때 참고하는 요인)	**LDL 콜레스테롤과 다른 위험요인을 더 철저히 관리**합니다 · **부모·형제자매·자녀**도 검사를 상담해 보세요
250 이상	**위험 2배 이상**	약을 쓸지 말지, 스타틴 강도, 목표 LDL을 진료에서 함께 정합니다

결과지 단위가 mg/dL이면 이 숫자와 바로 비교하지 마세요. 검사는 성인기에 **평생 한 번** — 경계치이거나 상태가 바뀌면(신장질환·폐경 등) 재검을 고려합니다.

Lp(a)와 아포B, 무엇이 다른가요

	Lp(a)	아포B
무엇을 보나	타고난 유전 수치	혈관벽에 쌓일 수 있는 입자의 개수
생활습관으로 변하나	운동이나 식사를 바꿔도 **크게 변하지 않습니다**	LDL 콜레스테롤과 함께 관리하는 수치입니다
몇 번 검사하나	**평생 한 번** — 경계치·상태 변화 시 재검 고려	LDL 콜레스테롤과 함께 진료에서 필요할 때 확인합니다
높으면	LDL과 다른 위험요인을 더 철저히 관리 · 가족 검사 상담	**작고 치밀한 LDL**이 많을 때 LDL 수치보다 위험을 더 잘 보여줄 수 있고, LDL 수치가 정상이어도 남은 위험이 있을 수 있습니다

결과가 높다면

함께 관리하는 것

이 결과를 참고해 **약을 쓸지 말지, 저강도·중강도·고강도 스타틴 중 어떤 것을 쓸지, 목표 LDL을 얼마로 정할지**를 진료에서 함께 정합니다

금연은 특히 중요합니다 · 혈압·혈당 등 다른 위험요인도 함께 확인합니다

아직 정해지지 않은 것

Lp(a)만을 낮추는 용도로 **승인된 치료제는 아직 없고, 여러 약이 임상 3상 시험 중**입니다

Lp(a) 관리를 위해 영양제·보충제를 복용하는 것은 권장하지 않습니다

운동만으로 수치가 크게 떨어지지는 않습니다

자세한 설명(진료실 설명 슬라이드): edu.gwanggyobarun.com/decks/endocrine/advanced-lipid-biomarkers/ · 내 LDL 목표: edu.gwanggyobarun.com/handouts/endocrine/ldl-target-by-risk/ · 연구 소개(VESALIUS-CV): edu.gwanggyobarun.com/decks/cardio/lp-a-cv-risk/

이럴 땐 바로 응급실로

Lp(a)·아포B 수치가 높다는 것 자체는 응급 증상이 아닙니다. 다만 갑자기 심한 가슴 통증, 팔다리 마비나 힘 빠짐, 말이 어눌해짐, 심한 호흡곤란이 있으면 결과 설명을 기다리지 말고 바로 응급실로 가시거나 119에 연락하세요.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 2022 EAS Lp(a) 합의문 · 한국지질·동맥경화학회 Lp(a) 입장문 2026 · 2026 ACC/AHA 이상지질혈증 가이드라인 · 2024 NLA 아포B 임상 컨센서스 · Emerging Risk Factors Collaboration, Lp(a)와 혈관질환(JAMA 2009)

본 자료는 공통 설명용입니다. 실제 목표 수치와 약물 선택은 전체 위험도, 기존 질환, 가족력에 따라 달라집니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/results/lpa-apob/